

Nexivarin 10 mg Tabletten — eCTD Einreichung
Modul 5 — Klinische Studien-Berichte

Einreichungstyp	NDA — 505(b)(1)	Sequenznummer	0000
Einreichungsdatum	2021-03-15	Abschnitt	5.3.4.2
Vorbereitet von	PharmaCorp Inc.	Vertraulichkeit	Proprietär und vertraulich

Inhaltsverzeichnis — 5.3.4.2 Klinischer Prüfbericht: Studie NXV-301

Abschnitt	Titel	Beschreibung
5.3.4.2	Klinischer Prüfbericht — Studie NXV-301	Phase III randomisiert, doppelblind, Placebo-kontrollierte Prüfung
Inhaltsangabe	Studie-Zusammenfassung	Multizentrisch; 902 randomisiert; 12-wöchige Behandlung; primärer Endpunkt SeDBP
Patientendemografie	Patientendemografie (ITT-Population, N=892)	Ausgewogene Ausgangsmerkmale über Behandlungsarme hinweg
Primäre Wirksamkeitsergebnisse	Primäre Wirksamkeitsergebnisse (ITT, LOCF)	SeDBP-Reduktion: -12,8 vs -4,2 mmHg; p<0,0001; Responderrate 68,4 % gegenüber 31,7 %
Sicherheitsergebnisse	Sicherheitsergebnisse (Sicherheitspopulation, N=902)	Ödem 13,9 % gegenüber 1,8 %; Keine Todesfälle im Zusammenhang mit dem Prüfpräparat

PharmaCorp Inc.
NDA-123456

Nexivarin 10 mg Tabletten

Abschnitt 5.3.4.2

Phase III Entscheidende Studie NXV-301

Einreichungstyp	NDA — 505(b)(1)
Sequenznummer	0000
Einreichungsdatum	2021-03-15
Vorbereitet von	PharmaCorp Inc.
Vertraulichkeit	Proprietär und vertraulich

5.3.4.2 Klinischer Prüfbericht: Studie NXV-301

Inhaltsangabe

Gegenstand	Details
Studie-Titel	Eine multizentrisch, randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Studie zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit von Nexivarin hydrochlorid 10 mg bei Patienten mit leichte bis mittelschwere essentielle Hypertonie
Studie-Nummer	NXV-301
Phase	III
Studie-Design	Parallelgruppen-, Doppelblind-, Placebo-kontrolliert, Multi-Zentrum
Anzahl der Standorte	48 Zentren (USA, Kanada, EU)
Dauer	12-wöchige doppelblinde Behandlung + 2-wöchige Nachbeobachtung
Eingeschrieben	902 randomisiert; 892 ITT; 874 PP
Primärer Endpunkt	Mittlere Veränderung vom Ausgangswert des sitzenden diastolischen Blutdrucks (SeDBP) in Woche 12
Sekundäre Endpunkte	SeSBP-Änderung; Responder-Rate (SeDBP <90 mmHg); Normalisierungsrate (SeDBP <85 mmHg); Lebensqualität (SF-36)
Randomisierungsverhältnis	1:1 (Nexivarin 10 mg: Placebo)
Blendung	Doppelblind; Tafeln mit identischem Aussehen
Statistische Analyse	ANCOVA mit Behandlung, Zentrum und Baseline als Kovariaten; LOCF-Imputation; alpha=0,05 (beidseitig)

Patientendemografie (ITT-Population, N=892)

Charakteristik	Nexivarin 10 mg (N=446)	Placebo (N=446)
Alter, Mittelwert ± SD (y)	52.4 ± 10.8	51.9 ± 11.2
Altersgruppe (y)	21 – 78	23 – 76
Männliches Geschlecht (%)	54.3%	52.7%
Weiß (%)	68.2%	67.5%
Schwarz (%)	18.6%	19.1%
Hispanisch/Latino (%)	9.4%	9.8%
BMI, Mittelwert ± SD (kg/m²)	28,9 ± 4,6	29.1 ± 4.8
Baseline-SeDBP (mmHg)	97,8 ± 5,4	98.1 ± 5.6
Baseline-SeSBP (mmHg)	154.6 ± 11.2	155.1 ± 10.8
Dauer der Hypertonie (y, Mittelwert)	5.2 ± 4.1	5.4 ± 4.3
Frühere Anwendung von blutdrucksenkenden Mitteln (%)	42.8%	44.2%
Diabetes mellitus (%)	14.6%	15.2%
Aktueller Raucher (%)	18.4%	17.9%

Primäre Wirksamkeitsergebnisse (ITT, LOCF)

Endpunkt	Nexivarin 10 mg	Placebo	LS-Mitteldifferenz (95 % KI)	p-Wert
Baseline-SeDBP (mmHg)	97,8 ± 5,4	98.1 ± 5.6	—	—
Woche 12 SeDBP (mmHg)	84.9 ± 7.2	93,9 ± 6,8	—	—
Änderung von Baseline SeDBP	-12,8 ± 0,6	-4,2 ± 0,6	-8,6 (-10,1 bis -7,1)	<0.0001
Baseline-SeSBP (mmHg)	154.6 ± 11.2	155.1 ± 10.8	—	—
Änderung von Baseline SeSBP	-18,4 ± 1,2	-7.3 ± 1.1	-11,1 (-13,8 bis -8,4)	<0.0001
Responder-Rate (SeDBP <90 mmHg)	68.4%	31.7%	OR 4.38 (3.10– 6.18)	<0.0001
Normalisierung (SeDBP <85 mmHg)	49.6%	18.4%	ODER 4.26 (2.92– 6.22)	<0.0001

Sicherheitsergebnisse (Sicherheitspopulation, N=902)

Parameter	Nexivarin 10 mg (N=451)	Placebo (N=451)
Irgendein TEAE	58.3%	50.1%
Schwere TEAE	1.8%	1.6%
Ernsthafte AE (SAE)	1.6%	1.3%
Einstellung aufgrund von AE	2.9%	1.1%
Ödem	13.9%	1.8%
Kopfschmerzen	7.1%	7.6%
Schwindel	3.1%	1.3%
Spülung	2.4%	0.4%
Ermüdung	4.2%	2.9%
Herzklopfen	1.2%	0.4%
Todesfälle	0	1 (unabhängig vom Prüfpräparat)

Fazit des Ermittlers

Die Studie NXV-301 erfüllte ihren primären Endpunkt und zeigte statistisch signifikante und klinisch bedeutsame Reduktionen von SeDBP und SeSBP mit Nexivarin 10 mg im Vergleich zu Placebo bei Patienten mit leichtem bis moderatem essentiellen Hypertonie über 12 Wochen. Das Sicherheitsprofil stimmte mit der Calciumkanalblocker-Klasse überein. Diese Ergebnisse unterstützen die Nutzen-/Risikobewertung und die behördliche Zulassung von Nexivarin 10 mg zur Behandlung von Bluthochdruck.